



菌特制錠

Bacide Tablets

衛署藥製字 第 010282 號

須由醫師處方使用

版本日期 2022-11-21

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每錠含

Sulfamethoxazole 400 mg

Trimethoprim 80 mg

1.2 賦形劑

本品含賦形劑 Microcrystalline Cellulose、L-HPC、Talc、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate。

1.3 劑型

錠劑。

1.4 藥品外觀

白色圓形平面錠，一面刻有“705”字樣，另一面有



2 適應症

由革蘭氏陽性菌、陰性菌所引起之呼吸道、胃腸道及泌尿道感染症。

3 用法及用量

3.1 用法用量

一般成人劑量：

3.1.1 抗菌劑

口服，錠劑2錠(800mg Sulfamethoxazole及160mg Trimethoprim)，每12小時一次。

3.1.2 抗原蟲劑，Pneumocystis Carinii肺炎

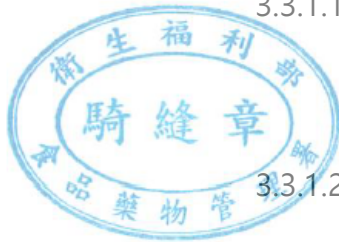
口服，錠劑2錠(800mg Sulfamethoxazole及160mg Trimethoprim)，每6小時一次。

3.1.3 一般成人處方限量

每天最多錠劑8錠(3.2g Sulfamethoxazole及640mg Trimethoprim)。

3.3 特殊族群用法用量

3.3.1 一般兒童劑量：



3.3.1.1 抗菌劑

嬰兒或體重40公斤以內之兒童：口服，每公斤體重20mg Sulfamethoxazole及4mg Trimethoprim，每12小時一次。

體重40公斤或以上之兒童：同一般成人劑量。

3.3.1.2 抗原蟲劑，Pneumocystis Carinii肺炎

嬰兒或體重32公斤以內之兒童：口服，每公斤體重25mg Sulfamethoxazole及5mg Trimethoprim，每6小時一次。

體重32公斤或以上之兒童：同一般成人劑量。

3.3.2 肝功能不全的病人需要減低劑量，其原則如下：

年齡	Creatinine清除率(mL/min)	劑量
	> 30	見一般成人劑量
成人	15 ~ 30	成人劑量的一半
	< 15	不宜使用
	> 30	見一般兒童劑量
兒童	20 ~ 30	兒童劑量的一半
	< 20	禁用

4 禁忌

4.1 由於Sulfamethoxazole可能導致新生兒核性黃疸，故一個月以下的嬰兒禁用。

4.2 對某一種磺胺藥過敏的病人，也可能對本藥過敏。

4.3 對下列藥物過敏的病人，對本藥也可能過敏：Furosemide、Sulfone類、Thiazide利尿劑、Sulfonylurea類或Carbonic Anhydrase抑制劑。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1 在空腹(飯前1小時或飯後2小時)時，伴一大杯(240mL)水共服。

5.1.2 應多喝水，使每天排尿量至少1200mL~1500mL。

5.1.3 應於規定時間按時服用，若錯過服藥時間儘速追服。如接近下一劑量，則其投藥法如下：

如原為一天2個劑量時，則漏服劑量停服，仍按正規投藥時間服用，但於下次正規投藥時間之

前5~6小時應加服一次。如原為一天3個或3個以上劑量，則漏服劑量停服，仍按正規投藥時間服用，但於下次正規投藥時間之前2~4小時加服一次或次一劑量加倍服用。

5.1.4 急性惡化的慢性支氣管炎之治療應至少持續10~14天；尿道感染至少持續7~10天；志賀桿菌

病至少5天；小孩急性中耳炎至少10天；Pneumocystis Carinii引起之肺炎至少14天。

5.1.5 嚴重皮膚不良反應(SCARs)：

上市後曾有嚴重皮膚過敏反應如史蒂文生氏強生症候群(Stevens-Johnson

Syndrome, SJS)、毒性

表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)、急性廣泛性發疹性膿疱症(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)和藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增高及全身症狀

症候群(Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS)的案例被通報。其中

包括致命的案例。如果出現嚴重皮膚不良反應相關症狀或癥候，應立即停藥並給予適當臨床處置。

5.4 實驗室檢測

5.4.1 Trimethoprim可能提高下列各檢驗值：膽紅素濃度、血尿素氮(BUN)、血清麩氨草醋酸轉氨酶

(SGOT)、血清麩氨丙酮酸轉氨酶(SGPT)及血清肌氨酸酐(Creatinine)之濃度。

5.4.2 在對病患監視方面，下列檢測特別重要：

5.4.2.1 完整的血球計數(CBC)：

對長期治療的病人，可能需要在治療前及期間每月測定，檢查有無血液惡病質。如果有任

何血液組成要素之計數有明顯的下降，應停用本藥。

5.4.2.2 尿分析：

對長期或高劑量治療的病人，可能需要在治療前及治療期間定期分析，檢查有無結晶尿及

泌尿結石的形成。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

Sulfamethoxazole與Trimethoprim都會通過胎盤。其對孕婦安全性尚未確立，應就其使用上之危險與效益加以考慮，因為大劑量的Trimethoprim在家鼠及兔子造成畸胎，且可能干擾葉酸的代謝而且它又以接近母體血清濃度的高濃度集中在胎兒循環系統、組織和羊膜液。雖然Sulfamethoxazole可能在胎兒血漿白蛋白結合部位將膽紅素取代出來，但是新生兒很少有高膽紅素血症及核性黃疸，主要是因為母體肝臟對膽紅素有高度的結合作用。

6.2 哺乳

Sulfamethoxazole與Trimethoprim都經由乳汁排泄，大約有母體劑量的1%之Sulfamethoxazole及0.2%之Trimethoprim出現在乳汁中；Sulfamethoxazole對葡萄糖-6-磷酸鹽去氫酶(G6PD)缺乏的新生兒可能造成溶血性貧血；Trimethoprim可能干擾授乳中的嬰兒的葉酸代謝；因此，哺乳婦使用本藥應其使用上之危險與效益加以考慮。

6.6 肝功能不全

本藥之使用應小心考慮。

6.7 腎功能不全

本藥之使用應小心考慮。

6.8 其他族群

6.8.1 葡萄糖-6-磷酸鹽去氫酶缺乏患者：本藥之使用應小心考慮。

6.8.2 吡咯紫質沉著症患者：本藥之使用應小心考慮。

6.8.3 葉酸不足所造成的巨初紅血球貧血：本藥之使用應小心考慮。

7 交互作用

7.1 本藥與尿鹼化劑共用時，可能增加Sulfamethoxazole在尿中之溶解度，而導致排泄增加，但Trimethoprim則減少。

7.2 本藥不宜與PABA共用，因為細菌可能捨Sulfamethoxazole而優先吸收PABA，而拮抗了Sulfamethoxazole之制菌作用。

7.3 口服抗凝血劑、口服降血糖劑、Methotrexate、Phenytoin或Thiopental與本藥共用時，Sulfamethoxazole可能取代其蛋白結合部位或抑制其代謝作用，而導致增加或延長其作用或毒性；

因此，在本藥治療期間或之後，調整這些藥物劑量是有其必要。

7.4 本藥不宜與Methenamine共用。因為Methenamine在酸性尿中分解為甲醛，甲醛可能與Sulfamethoxazole形成不溶性沉澱物，而且也可能增加形成結晶尿的危險。

7.5 Oxyphenbutazone或Phenybutazone與本藥共用時，由於Sulfamethoxazole取代其血漿蛋白結合部位，作用可能加強。

7.6 在治療腦膜炎或其他必須迅速殺菌的狀況，Penicillin類最好避免與本藥共用。因為制菌性的藥物可能干擾Penicillin類的殺菌作用。

7.7 Probenecid與本藥共用時，可能降低Sulfamethoxazole之腎小管分泌，導致Sulfamethoxazole血清濃度

及毒性增加且大為延長；因此，在Probenecid治療期間及其後，本藥之劑量調整有其必要，而且在長期Probenecid治療中，Sulfamethoxazole血清濃度之測定也有助益。

7.8 本藥與Sulfinpyrazone共用時，後者可能取代Sulfamethoxazole的蛋白結合部位，且可能降低腎排泄，導致Sulfamethoxazole血清濃度及毒性增加；因此，在Sulfinpyrazone治療期間及其後，本藥之劑量調整是有其必要。

7.9 抗癌藥或2,4-Diaminopyrimidine類(如Chloroguanide、Pyrimethamine)不宜與本藥共用，在其他藥酸拮抗劑治療過程之間也不宜投用本藥，因為Trimethoprim有造成骨髓發育不全或巨初紅血球貧血之可能。

7.10 本藥與Rifampin共用時，可能大為增加Trimethoprim之排泄而縮短其半衰期。

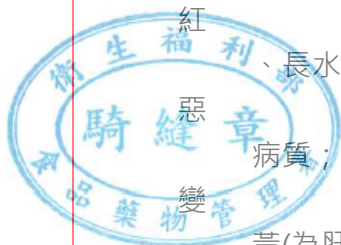
8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

8.1.1 投用本藥如有下列副作用時應予醫療照應：

皮膚對陽光的敏感度增加、癢或發疹(為過敏反應)，關節和肌肉痛(為Stevens-Johnson症候群)

，吞嚥困難(為Lyle氏症候群)，皮膚蒼白或咽痛或異常出血或瘀傷(為血液惡病質)，皮膚發



紅、長水疱、剝皮或鬆弛(為Stevens-Johnson症候群；血液惡病質)，無法解釋的發燒(為血液惡病質；過敏反應)，異常疲倦或虛弱(為Stevens-Johnson症候群；血液惡病質)，眼睛或皮膚黃(為肝炎)，尿中有血或背部下方痛或解尿時痛或灼熱感(為結晶尿；血尿)，頸部前方腫脹(為

甲狀腺功能障礙；甲狀腺腫)，藍色指甲、唇或皮膚或呼吸困難(為變性血色蛋白血症)。

8.1.2 服用本藥有下列副作用持續或造成困難時應予醫療照應：

腹瀉、頭昏眼花、頭痛、異常味覺、食慾不振、噁心、嘔吐、口或舌痛及胃痙攣或痛。

8.1.3 服用本藥若造成葉酸缺乏時，可與葉酸鹽類共用，由於細菌不能利用執行任務的葉酸鹽，因此，並不會干擾本藥之抗菌活性。如果有骨髓抑制的徵候出現，應停用本藥。為了要恢復正常造血，可肌肉注射3~6mg Leucovorin (Folinic Acid)，每天一次，持續3天或視需要而定。

對於Trimethoprim的慢性過量，可給高劑量Leucovorin，而且(或)持續一段很長的時間。

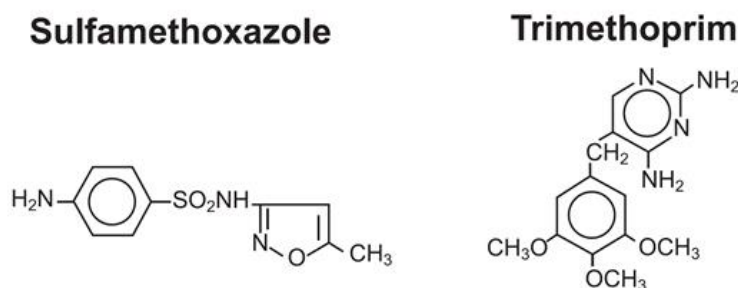
8.1.4 嚴重皮膚不良反應(SCARs)上市後曾有嚴重皮膚過敏反應，包含「史蒂文生氏強生症候群(SJS)、毒性表皮壞死溶解症(TEN)、急性廣泛性發疹性膿疱症(AGEP)和藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增高及全身症狀症候群(DRESS)的案例被通報，其中包括致命的案例。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

本品係由Sulfamethoxazole與Trimethoprim以5:1之重量比配合而成之複方劑型，具有廣效性抗菌作用。Sulfamethoxazole為中等作用期磺胺藥，Trimethoprim為親脂性的弱鹼。其化學結構式分別為：



10.1 作用機轉

制菌性抗感染劑

10.1.1 Sulfamethoxazole為Paraaminobenzoic Acid (PABA)之結構類似物，它在細菌合成Folic

Acid過程中，競爭性抑制了負責把PABA併入Dihydrofolic Acid的Dihydropteroate合成酶，

由此阻斷Dihydrofolic Acid之合成，減少了具代謝活性的Tetrahydrofolic Acid的量，此Tetrahydrofolic Acid為Purine、Thymidine及DNA合成上的輔助因子。只要是必須合成Folic Acid的細菌，對此藥均具感受性，因此，磺胺藥物的作用會被PABA及其衍生物如

Procaine及Tetracaine所拮抗，也會受到那些能提供細菌生長所需之必需組成物的膿或分解產物所拮抗。

10.1.2 Trimethoprim為結構上與Pyrimethamine相關的親脂性弱鹼，與細菌的Dihydrofolate Reductase結合，並可逆地抑制其活性，而選擇性地阻止Dihydrofolic Acid還原成有功能的

Tetrahydrofolic Acid，正好緊接於Sulfamethoxazole所阻止的次一步驟，由此干擾核酸及蛋

白質的製造。細菌的Dihydrofolate Reductase與Trimethoprim之結合強度大約比相當的哺乳

類酵素高出50,000~60,000倍。

10.1.3 由於Sulfamethoxazole與Trimethoprim分別抑制Tetrahydrofolic Acid生合成的連續兩個步驟，

兩者共用時會產生加成作用。

10.2 藥效藥理特性

詳見10.1。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

11.1 Sulfamethoxazole

11.1.1 口服吸收較慢，但吸收完全，約達90%~100%，約2~4小時達血中最高濃度。廣泛地分佈

於身體各組織及包括胸膜液、腹膜液、滑膜液和眼液的各體液中。容易通過胎盤障壁；擬

似分佈體積約0.36公升/公斤；大約有60%~68%與蛋白結合，而乙醯化代謝物比游離型本

藥更易與蛋白結合。本藥會與膽紅素競爭球蛋白，早產兒或新生兒可能出現核性黃疸。腎

功能嚴重受損的病患，此種結合減少。只有其游離、未結合型才具有抗菌活性。

11.1.2 本藥在肝中代謝(約15%~25%)，主要藉乙醯化反應形成不具活性但仍保有本藥毒性的代謝物。一些尿甘酸化合物結合反應也可能在肝中出現。代謝作用隨著腎功能不全而增加

，隨著肝衰竭而降低。

11.1.3 本藥主要經腎小管過濾而由腎臟排泄，有一些本藥和代謝物也經由腎小管分泌和再吸收。

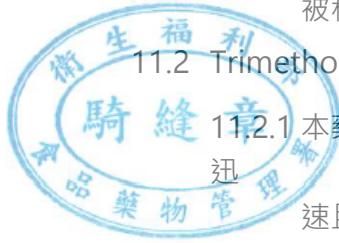
大約投藥後半小時尿中達最高濃度，24小時內約有16%~33%以原型藥排泄。於鹼性尿液

中，排泄增加。乙醯化代謝物相當不溶性。少量的本藥可由糞便、乳汁、膽汁及其他身體

分泌排泄。

11.1.4 本藥之半衰期約為6~12小時，但末期腎衰竭病人則長達20~50小時。它可由血液透析而

被移除。



11.2 Trimethoprim

- 11.2.1 本藥口服吸收迅速且完全(90%~100%)，在1~4小時內達到血清平均最高濃度；吸收後迅速且廣泛地分佈到各組織及體液，包括有腎、肝、脾、支氣管分泌物、唾液及前列腺組織及其液體。在膽汁、眼房水、骨髓和海綿骨也有，但緻密骨則否，此外腸黏膜及精液等也
已證實其存在。其中膽汁中的濃度高於血清濃度；腦脊髓液中的濃度達血清濃度的30%~50%，前列腺組織及其液體也有相當高濃度；腎臟、尿中和肺的濃度通常高於血清濃度；陰道液濃度高達一般血清濃度的3倍。可通過胎盤障壁。擬似分佈體積約為1.2~2公升/公斤。
- 11.2.2 本藥有中等至高等蛋白結合性；由肝臟代謝，約10%~20%經由氧-去甲基反應(O-Demethylation)、環上氮-氧化反應及 α -羥基化反應代謝成無活性的代謝物；代謝物可
能為游離態或結合態。
- 11.2.3 本藥主要由腎臟排泄，在24小時內約排泄掉40%~60%。主要藉腎小球過濾及腎小管分泌。
。這些量中，約80%~90%以原型藥排泄，其他的則以不具活性的代謝物排泄。在酸性尿中排泄增加，鹼性尿中則減少。少量由糞便(約4%)、膽汁及乳汁排泄。
- 11.2.4 本藥之半衰期在正常腎功能病人約8~10小時，在無尿的病人則長達20~50小時。血液透析可將本藥移除，因此，施予透析後，應給予全部維持劑量。腹膜透析不會把本藥自超
劑
量下之血液中移除。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

4~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

13.2 效期

超過包裝上所標示的使用期限(Exp. Date)之後，請勿使用。

13.3 儲存條件

儲存於25°C以下。

13.4 儲存注意事項

應儲存於避光處所。

製造廠

111.11.21

榮民製藥股份有限公司

桃園市中壢區中山東路3段447號

藥商

榮民製藥股份有限公司

桃園市中壢區中山東路3段447號

